

GUÍA ENTRENATZAILE

Lo que nadie te cuenta sobre la erección después de los 50

Una guía honesta sobre qué cambia de verdad, qué puedes mejorar, y qué merece que vayas al médico.

ENTRENATZAILE · ALAIN ZULAIKA

Si has empezado a notar que las cosas no funcionan igual que antes, esto es lo primero que deberías saber: **no estás roto, no estás solo, y una buena parte de lo que notas se puede trabajar.**

Lo segundo: casi ningún hombre de tu edad habla de esto en voz alta. Muchos lo están viviendo en silencio, convencidos de que es el final de algo. No lo es. Pero como nadie lo cuenta, cada uno se lo come solo y saca sus propias conclusiones —normalmente las peores.

Esta guía es para romper ese silencio con información seria. Sin dramas y sin milagros. Solo lo que dice la ciencia, contado en cristiano.

Separemos dos cosas que casi todo el mundo mezcla

Cuando un hombre nota cambios en la erección, suele meter todo en el mismo saco: "me hago mayor, esto es lo que hay". Y ahí está el error más caro. Porque hay **dos cosas distintas** ocurriendo a la vez:

- **Una parte es la edad de verdad.** Real, gradual, lenta. Existe.
- **Otra parte —a menudo la más grande— no es la edad. Es tu salud, tus hábitos y tu forma física.** Y esa parte se puede cambiar.

Las dos se sienten igual desde dentro. Parecen "hacerse mayor". Pero una es inevitable y la otra no. Distinguir las lo cambia todo, porque significa que **tienes más margen del que crees.**

Lo que sí cambia con la edad (y no vale la pena pelear)

Seamos honestos, porque prometerte lo contrario sería mentirte:

- La testosterona baja poco a poco con los años. **Pero ojo:** en hombres sanos, esa bajada es lenta y suele mantenerse en niveles normales. No hay una "menopausia masculina" que te apague de golpe.
- Los vasos sanguíneos pierden algo de elasticidad con la edad. Y como una erección es, en el fondo, un tema de riego sanguíneo, eso se nota.

Esto es el suelo. No lo vas a revertir a base de fuerza de voluntad ni de suplementos. Aceptarlo no es rendirse: es dejar de gastar energía donde no la hay para gastarla donde sí.

Lo que Sí puedes mejorar (y cuánto)

Aquí viene la buena noticia, y viene con datos reales, no con humo.

El ejercicio aeróbico mejora la erección. No "ayuda un poco" de forma vaga: mejora de forma medible, y la mejora es comparable a la que consiguen tratamientos médicos como la terapia de testosterona. Con una diferencia enorme a su favor: no tiene efectos secundarios ni te cuesta una receta.

Cuanto antes empieces, más rentable es. Si acabas de notar cambios leves, el ejercicio por sí solo puede bastar para notar la diferencia. Si esperas a que la cosa esté muy avanzada, seguirá ayudando, pero hará falta más. El mejor momento para moverte es cuando empiezas a notarlo, no cuando ya es un problema gordo.

¿Qué tipo de ejercicio, y cuánto?

Lo que la ciencia ha visto funcionar:

- **Ejercicio aeróbico** (caminar rápido, bici, nadar, correr suave): la palanca principal. Es lo que más y mejor mejora la erección.
- **Frecuencia:** entre 3 y 5 veces por semana.
- **Duración:** de 30 a 60 minutos por sesión.
- **Constancia:** los resultados se ven a partir de unas semanas y se asientan hacia los 6 meses.

No hace falta convertirse en atleta. De hecho, pasarse —volumen extremo tipo maratón— puede jugar en contra y bajar el deseo. **Ni poco ni demasiado: constante.**

Dos mitos que te están costando dinero y energía

"Levantar pesas me subirá la testosterona."

No es así. El entrenamiento de fuerza es fantástico para tu salud, tu músculo y tu forma física —y por esas vías ayuda—, pero no sube tu testosterona de base. Si lo haces esperando eso, te llevarás una decepción. Hazlo por lo que sí da.

"Los boosters de testosterona y suplementos milagro."

La industria de los suplementos vive de tu miedo. Lo que tiene evidencia sólida detrás es el ejercicio y —si te sobra peso— perder grasa. Los botes con nombres agresivos, no. (Y no, la soja no te "afemina": otro mito desmontado.)

Lo más importante de toda esta guía

Si te llevas una sola cosa, que sea esta:

La erección puede avisar del corazón

Una erección que empieza a fallar puede ser la primera señal de un problema cardiovascular que aún no da la cara

No es alarmismo. Es de las cosas mejor demostradas de todo este tema. Las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón, así que cuando algo va mal en el sistema circulatorio, **suele notarse ahí antes que en ningún otro sitio** —a veces años antes de que haya cualquier síntoma cardíaco.

Por eso, si has empezado a notar cambios sin causa obvia, la recomendación no es solo "muévete más". Es también, **al menos una vez, ir al médico a que te revisen el corazón y la circulación**. No porque algo vaya mal seguro, sino porque es la ocasión perfecta para adelantarte. Tu cuerpo te está dando un aviso temprano gratis. Aprovéchalo.

Entonces, ¿por dónde empiezo?

- 1 No lo vivas en silencio ni lo des por perdido.** Buena parte es trabajable.
- 2 Muévete, sobre todo en aeróbico.** 3-5 veces por semana, con constancia. Es la palanca con más respaldo.
- 3 Olvídate de suplementos milagro.** El dinero, mejor en zapatillas.
- 4 Ve al médico una vez** para descartar que sea una señal cardiovascular. Esto no es negociable.
- 5 Empieza pronto.** El margen de mejora es mayor cuanto antes actúas.

Una última cosa

Saber qué hacer es la parte fácil. Hacerlo, y sostenerlo en el tiempo, es donde casi todo el mundo se cae. No por falta de ganas, sino porque empezar solo desde cero, sin saber si lo estás haciendo bien, cansa y desanima.

Si has leído hasta aquí es porque esto te importa de verdad. Si en algún momento quieres dejar de dar palos de ciego y que alguien te acompañe a hacerlo bien —a tu ritmo, con un plan pensado para ti y con alguien pendiente de que sigas—, [escribeme, llamada y hablamos](#) (o haz clic ahí y se abre tu correo listo). **Sin compromiso.** A veces una sola conversación honesta ya te ahorra meses de dudas.

Esta guía resume evidencia científica actual con fines informativos. No es consejo médico ni sustituye la valoración de un profesional sanitario. La disfunción eréctil, especialmente si es de aparición reciente, debe ser evaluada por un médico por su posible valor como señal cardiovascular temprana.